

Economie de la santé

A. Introduction

1. Santé

Une **bonne santé** est très appréciée et a une **grande valeur**. L'OMS définit la **santé** comme un état de bien-être complet physique, mental et social et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. **Les principaux déterminants de la santé** sont les suivants : génétique, alimentation, mode de vie, profession, éducation, état civil, environnement, choix individuels, santé publique, criminalité, accidents et guerres.

Les soins de santé ne sont qu'un facteur conduisant à la production de santé et il faut savoir que le progrès médical a conduit à des améliorations significatives en matière de santé (vaccinations, antibiotiques, anesthésiques, chirurgie, produits pharmaceutiques/biotechnologiques, diagnostic tests/imagerie et génétique).

2. Soins de santé

Les soins sont consommés car on anticipe leurs effets positifs/bénéfiques sur la santé. On accorde de la valeur à l'amélioration de l'état de santé induite par l'utilisation des services de santé mais pas aux soins en eux-mêmes. La demande de soins de santé est une fonction dérivée de la demande de bonne santé. En somme, la **demande en soins de santé est responsable de l'augmentation des coûts**.

La santé n'a **qu'une valeur d'usage** contrairement aux soins de santé qui n'ont pas de finalité en eux-mêmes, mais une valeur d'échange. La demande de soins de santé est une fonction dérivée de la demande de bonne santé. Ainsi, l'analyse économique se fait sur les soins de santé

Le marché de l'assurance doit être opposé au marché des soins de santé. Le marché de l'assurance **précède le marché des soins** (c'est la souscription d'une police d'assurance qui permet de financer les soins). L'analyse économique aura des implications différentes selon que l'on traite de l'un ou l'autre. Les soins de santé sont des **biens**

économiques particuliers dits **des biens publics** (voire mixtes) par opposition à des biens privés. En d'autres termes, ils suivent le principe de non-rivalité et de non-exclusion. On parle **de non-rivalité** lorsque la consommation du bien par un agent n'a aucun effet sur la quantité disponible de ce bien pour les autres individus. En revanche, on parle de **non-exclusion** quand une fois que le bien public est produit, tout le monde peut en bénéficier.

	Rivalité	Non-rivalité
Exclusif	Bien privé	mixte
Non exclusif	mixte	Bien public

2.1 Caractéristiques du marché des soins de santé

Les soins de santé sont des services qui se caractérisent par **des effets externes** c'est à dire que les décisions de consommation d'un agent affectent directement la satisfaction des autres sans que le marché fasse payer ou rétribue l'agent pour cette interaction.

Les biens de santé se caractérisent aussi par l'importance de la **valeur d'option** qui leur est attribuée par les consommateurs, car le consommateur retire une utilité de l'existence même d'infrastructures médicales, pour lesquelles il est prêt à payer un certain prix afin de les utiliser plus tard. Il faut savoir que les biens de santé sont **des biens d'expérience** c'est à dire que la qualité ne peut pas être évaluée avant d'avoir expérimenté le bien. Comme il est difficile d'observer la qualité sans expérience, le consommateur ne peut pas facilement comparer les caractéristiques des produits ou obtenir de l'information grâce aux autres consommateurs, on se retrouve donc dans des **biens de confiance** (difficulté d'évaluer la qualité même après usage du produit).

3. Problèmes d'information imparfaite et d'incertitude

Le médecin et les patients **n'ont pas la même quantité d'information à disposition**, on parle donc d'asymétrie d'information entre le fournisseur et le demandeur de soins. L'obtention de l'information supplémentaire est

coûteuse et il y a un potentiel pour le fournisseur "d'exploiter" le patient (pousser le patient à consommer). L'incertitude est **multidimensionnelle**, le patient ne peut pas toujours se réapproprier l'information et il y a une dimension émotionnelle forte.

Il existe **une incertitude sur la survenue de la maladie et sur l'efficacité des** traitements (plus de 50% des traitements). De plus, les individus peuvent affecter la probabilité de survenue de la maladie. Les conséquences de cette incertitude et de cette asymétrie d'information se retrouvent dans deux effets (étudiés dans le marché de l'assurance) : **le risque moral et la sélection adverse**. A ces deux facteurs, il faut rajouter une hétérogénéité des patients, des professionnels de santé, de l'organisation et du financement du système.

4. Risque moral

Le risque moral nous dit que le fait même d'être assuré **modifie le comportement des bénéficiaires** dans le sens d'une **moindre prévention** et d'une utilisation des soins de santé **supérieure** à celle qu'ils choisiraient s'ils payaient l'intégralité du prix. On parle aussi de risque moral lorsque les personnes assurées s'exposent davantage aux risques de surconsommation des soins médicaux. Il est donc indispensable de responsabiliser l'usager pour éviter un gaspillage des ressources.

5. Sélection adverse

La sélection adverse ou anti-sélection est « *un phénomène économique qui joue un rôle important dans les domaines de l'assurance et de la gestion du risque, par lequel une offre faite sur un marché aboutit à des résultats inverses de ceux souhaités, à cause d'asymétries d'information* ». Il y a une sélection adverse lorsque les individus **choisissent leur niveau de couverture d'assurance en fonction de leurs dépenses espérées**. La sélection adverse provient de la difficulté pour l'assureur à **observer le type de consommateur au moment de la signature du contrat**. Les assureurs attirent donc les individus souffrant d'une forte morbidité et ayant une forte aversion pour le risque.

Les mauvais risques ont une forte tendance à s'assurer, raison pour laquelle ils sont surreprésentés dans la population des assurés, ce qui peut mettre en péril l'équilibre budgétaire de la compagnie. De plus, une augmentation des primes accentue le problème en chassant les bons risques.

Pour se prémunir, les assureurs privés développent des stratégies d'écramage des risques (sélection des meilleurs risques par des questionnaires médicaux) ce qui provoque l'exclusion des mauvais risques et donc des inégalités d'accès aux soins.

La sélection adverse et le risque moral conduisent donc à **l'inefficacité** voire parfois à la défaillance du marché de l'assurance.

6. Régulation du marché des soins de santé

L'analyse économique indique que la production, si elle est laissée à l'instigation des seuls agents, est **insuffisante** du point de vue du bien-être de la société. On parle alors de **défaillance du marché**, ce qui légitime **l'intervention de l'état** dans le financement et la régulation des soins médicaux.

L'État doit intervenir au moyen d'obligations et /ou d'interdictions légales et de contrôles pour atteindre les 3 objectifs inhérents à tout système de santé :

- Limiter les dépenses excessives
- Assurer une **qualité optimale** des soins
- Assurer **l'équité** des états de santé et de l'accès aux soins

Pour ce faire, il existe plusieurs outils notamment la régulation de la demande et la régulation des offreurs de soins.

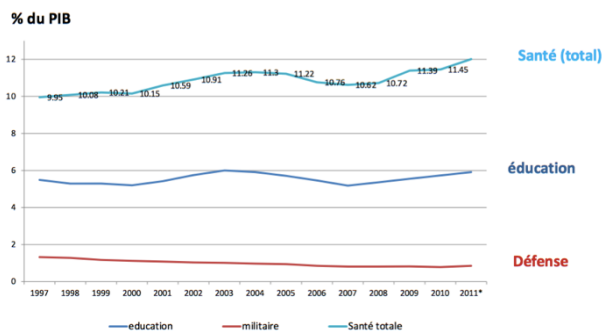
7. Pourquoi s'intéresser à l'économie de la santé

L'économie représente une grande part de l'économie et il y a **une demande croissante en soins**, mais la crise financière a fait émerger les questions d'accessibilités financière.

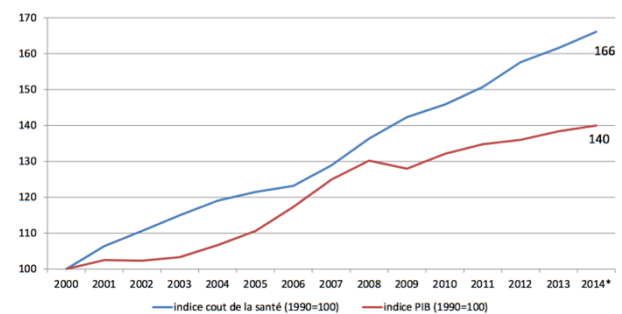
L'économie apporte une prise de conscience sur **la quantité limitée** de ressources et nous dit qu'il existe un coût d'opportunité lié à l'utilisation de ces ressources d'où le besoin de les utiliser de **manière efficiente**.

8. Coûts et performance des systèmes de soins

La santé représente plus de 11% du PIB en Suisse, avec une légère croissance ces dernières années. La **croissance des dépenses de santé** sur la période 2000-2014 est **supérieure à la croissance du PIB**, ce qui va finir par poser problème. En 2014, les coûts du système de santé se sont élevés à **71 milliards**, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Cela représente en moyenne **725.- par mois et par habitant**.



Evolution des coûts du \$ de santé et du PIB, valeur nominale 2000-2014 base 100=2000



La croissance des dépenses de santé était moindre après 2009 (crise financière) grâce à une prise de conscience. On sait que **la croissance du marché des génériques** a contribué à la réduction des dépenses pharmaceutiques (augmentation de la part des génériques remboursés).

9. Performances sanitaires

On se demande quels sont les résultats quand on alloue beaucoup d'argent à la santé. On doit donc **juger les performances des systèmes de santé**. Pour mesurer ces bénéfices, on dispose de plusieurs indicateurs comme **l'espérance de vie, la mortalité, l'état de santé subjectif ou encore les accès aux soins**.

Depuis plusieurs années, on a remarqué **une augmentation de l'espérance de vie à la naissance ou globalement**, une augmentation des années de vie en bonne santé et **une diminution de la mortalité infantile**. Attention, la perception de l'état de santé **est différente** en fonction de la classe économique à laquelle on appartient. Par exemple, les personnes avec **un revenu plus bas** ont tendance à se percevoir **en moins bonne santé**. L'âge joue également un rôle, puisque **les personnes âgées** ont également tendance à **se percevoir en moins bonne santé**.

10. Coûts et financement du système de santé Suisse

Le SHA (*System of Health Accounts*) est basé sur trois questions :

- Où va l'argent ?
- Quelles prestations ont été fournies et quels biens ont été consommés ?
- D'où provient l'argent ?

Les coûts sont ainsi considérés dans l'optique **des fournisseurs de santé, des prestations et des agents payeurs** (régime de financement et source de financement).

Les coûts de la santé sont ventilés **selon les fournisseurs de biens et services et les prestations**. La nomenclature des prestations, ressemblante sur certains points à celle des fournisseurs de soins, est cependant fondée sur une approche différente. Elle repose sur une approche fonctionnelle. Les prestations

ou les activités économiques en rapport avec la santé sont répertoriées **selon leur fonction** et non selon l'organisme fournissant le bien ou le service.

En analysant les **fournisseurs**, on remarque que les hôpitaux et les prestataires de services ambulatoires représentent la plus grande partie des dépenses de santé. Si on fait cette répartition en fonction des **prestations**, on remarque c'est **les soins en milieu hospitalier** qui représentent la plus grande part des dépenses du système de santé, puis les soins ambulatoires.

11. Financement du système de santé

Le financement du système de santé est analysé sous deux angles différents : **le régime et la source de financement**.

Régimes de financement

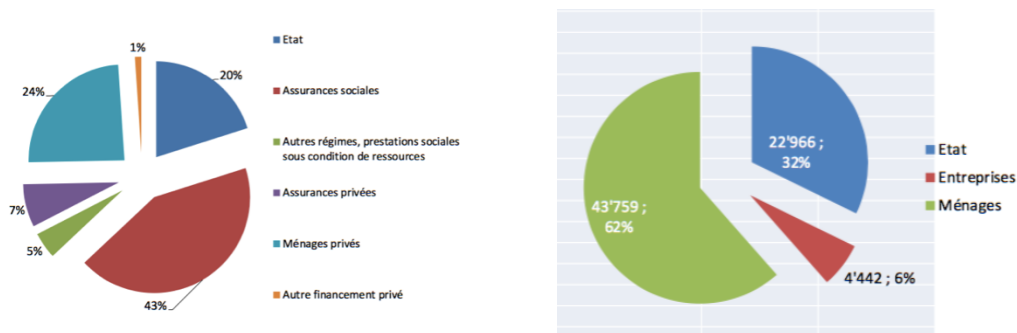
Le financement du Système de santé est analysé **selon le régime de financement**. Les principaux régimes sont :

- **L'Etat** (confédération, cantons, communes) pour toutes les prestations qu'il finance directement (prévention, administration, subventions aux fournisseurs de prestations)
- **Les assurances sociales** (assurance-maladie, assurance-accidents, etc.)
- **Les autres régimes**, c'est-à-dire les prestations sociales sous conditions de ressources (prestations complémentaires, aides cantonales)
- **Les assurances privées**
- **Les ménages privés**, au titre de participation aux frais dans l'assurance-maladie ou de paiement de prestations non couvertes par les autres régimes (Etat, assurances sociales, etc.)
- **Les organisations sans but lucratif**, en particulier les ligues de santé.

Le principal **régime** de financement est issu des assurances sociales (40%), puis on retrouve les ménages privés et l'Etat.

Source de financement

La majorité de la **source** de financement provient des ménages (62%), puis on retrouve l'Etat et enfin les entreprises.



B. Les facteurs explicatifs des dépenses de santé

La **croissance démographique** affecte directement la croissance des dépenses de santé. L'évolution de la structure démographique influence également la croissance des dépenses de santé, notamment à cause d'une augmentation de la proportion de personnes âgées, mais aussi d'une diminution de la proportion de personnes âgées de moins de 15 ans.

Des estimations ont été faites pour les années 2080 et on pense que la proportion de personnes âgées de 80 ans ou plus va plus que doubler pour arriver à près de 12%. On voit que plus la personne est âgée, plus le coût annuel en dépense de santé augmente. Ainsi, sans surprise, les dépenses apparaissent comme une fonction croissance de l'âge.

On voit que l'âge et la consommation de soins sont clairement liés car d'une part la probabilité de recourir au système de soins augmente avec l'âge et d'autre part, le volume d'actes par patient augmente avec l'âge. S'il est pertinent de prédire que le vieillissement contribue à augmenter les dépenses de santé, **il est erroné d'y voir la source principale de la croissance à venir de ces dépenses.**

En effet, en 2000, les dépenses de santé étaient inférieures à celles de 2013 et cela, quel que soit l'âge ! Cependant, en regardant les montants absolus, on voit que la dépense diminue chez les personnes âgées (moins de personnes).

On pense que cette évolution peut être expliquée par une morbidité, le progrès médicale et l'utilisation des nouvelles technologies.

La morbidité

L'âge est **un indicateur très imparfait** de la morbidité. En l'absence d'une information plus précise rarement disponible, l'âge est un indicateur de la morbidité car la prévalence de la plupart des affections augmente avec l'âge. Mais **c'est la morbidité et non l'âge en soi** qui explique que le profil des dépenses de santé soit une fonction croissante de l'âge. En effet, on constate que l'âge n'a plus d'influence significative sur les dépenses de santé si l'on tient compte du niveau d'invalidité et de la morbidité, c'est-à-dire des maladies chroniques affectant l'individu. En matière de dépenses de soins, ce qui est important ce sont les besoins et donc la morbidité plutôt que l'âge.

Certaines études empiriques montrent que le nombre d'années de vie sans incapacités stagne, de même que les années de vie avec incapacité sévère. En Suisse, les données s'ancrent dans cette tendance et montre que **l'allongement de la vie n'induit pas l'augmentation des années en mauvaise santé. Ainsi, dans les années futures proches, l'allongement de l'espérance de vie de la population suisse ne devrait pas constituer la cause majeure de l'augmentation des coûts de morbidité.**

Préférences

L'évolution **des préférences et des attentes** des individus envers leur santé participe à l'augmentation de la consommation médicale. La perception de la santé, et de ce qu'est une bonne santé, **dépend du contexte social et culturel**. On a également observé un déplacement au cours du temps de la frontière entre le «sain» et le «malsain» et une évolution qui s'explique par le progrès dans la connaissance et la technique médicale qui fait naître des attentes élevées.

Enfin, il faut aussi penser à la commercialisation de la santé avec un marketing intense auprès des prestataires de soins, mais aussi du grand public, contribuant à modifier la perception des individus et à créer le besoin.

Actuellement, on pense que le changement de pratique médicale (progrès techniques, expansion du volume des prestations est le facteur le plus important pour expliquer cette augmentation concernant les coûts de la santé. En somme, près de 60% des dépenses s'expliquent par des facteurs autres que des facteurs démographiques.

- **Les pratiques médicales**
 - Changement de comportement des patients (propension à consulter)
 - Changement de comportement des médecins
- **Les nouvelles technologies (y compris les médicaments).**

Progrès médical

En santé, le terme progrès médical est plus associé à l'augmentation des dépenses de santé.

Substitutions du traitement

Les principales raisons qui expliquent une substitution sont les suivantes :

- Augmenter l'efficacité du traitement
- Augmenter le succès du traitement
- Réduire les effets secondaires
- Gagner du temps et réduire les coûts